



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di MILANO

Sez. II CIVILE

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Walter Saresella	Presidente
dott. Antonio Corte	Consigliere
dott. Elena Mara Grazioli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **33/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in VIA
GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso lo studio dell'Avvocato IACONA DONATELLA,
che la rappresenta e difende

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in VIA
GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso lo studio dell'Avvocato IACONA DONATELLA,
che la rappresenta e difende

Parte_2 (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliato in VIA
GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso lo studio dell'Avvocato IACONA DONATELLA,
che la rappresenta e difende

APPELLANTE

contro

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente
domiciliata in VIA G. GRIZIOTTI 1 20145 MILANO presso lo studio dell'Avvocato FEDELI
RENATO, che la rappresenta e difende

APPELLATO

CONCLUSIONI

NOTE DI TRATTAZIONE CP_3 e CP_4

nell'interesse di

Parte_1 , Controparte_1 e Parte_2 , con l'avv. Donatella Iacona

PREMESSO

- il provvedimento del 26.10.2020, con il quale la Corte ha disposto la trattazione scritta della causa in epigrafe all'udienza del 03.11.2020, i signori Parte_1 , CP_1 e Pt_2 insistono nel contenuto tutto dell'atto d'appello e rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5315/2019 del 05.06.2019, non notificata così giudicare:

NEL MERITO,

IN PRINCIPALITA'

- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_5 nella causazione della morte di Persona_1 e per l'effetto, condannare il convenuto CP_5 al pagamento di tutti i danni patiti e patienti, subiti dagli attori, ciascuno per il proprio titolo, danni tutti patrimoniali e non (in breve nulla di escluso o eccettuato), da liquidare con la relativa condanna nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo ex artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge, il tutto secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, nella misura di € 427.260,00=, o nella diversa somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, gradando da un massimo di € 142.420,00 ad un minimo € 23.740,00 per ciascun danneggiato, dando atto che la convenuta in primo grado ha versato di sua sponte € 10.000,00 a ciascun attore.

In via istruttoria

Si chiede, la rinnovazione della CTU medico legale esperita in primo grado volta ad accertare la causa della morte del signor Persona_1 , per le motivazioni addotte nel verbale del 30.11.2018 e nell'atto di appello.

Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:

1. “vero che il signor Parte_1 ha sempre convissuto con il fratello Persona_1 , in Bollate, prima in via G. Verdi n.40 e poi in via Monte Tofane n.8, come da documenti 8 e 9 che si rammostrano”

2. “vero che **Parte_2** ha convissuto, unitamente ai propri figli, con il signor **CP_6** [...] anche dopo sposata, in Bollate in via Giuseppe Verdi n.40 dalla nascita fino all’anno 1995, come da documento 10 che si rammostra.”
3. “Vero che la signora **Controparte_1** dopo il matrimonio, ha sempre abitato, come da documento 11 e 12 che si rammostrano, in Bollate via Monte Grappa n.11 a circa cento metri di distanza dall’abitazione di **Persona_1** sita in Bollate via Monte Tofane 1”;
4. “Vero che i quattro fratelli **Per_1** trascorrevano insieme quasi tutte le domeniche, a pranzo o a cena, le feste natalizie, pasquali, e le ricorrenze dei vari compleanni o altri eventi di figli e nipoti”;
5. “Vero che **Parte_2** dopo la morte del padre, avvenuta nel 1976, quando la predetta aveva 5 anni, considerava come padre il fratello maggiore **Persona_1** di anni più anziano”
6. “Vero che **Pt_1** , **CP_1** e **Pt_2** alternandosi, si sono sempre presi cura del fratello **Per_1** [...] , bisognoso di assistenza in casa ed in varie strutture sanitarie, vista la patologia da cui era affetto, come da doc.2 che si rammostra”
7. “Vero che, in particolare, nell’anno 1998 **Persona_1** veniva dimesso dall’ **CP_5** in condizioni di assoluta infermità ed in tale occasione, le sorelle **CP_1** e **Pt_2** ed il fratello **Pt_1** , alternandosi, lo hanno accudito in casa per circa 8 mesi, fino a quando **Per_1** non venne ricoverato in un centro riabilitativo”
8. “Vero che tra i fratelli **Pt_1** , **Per_1** , **CP_1** e **Pt_2** intercorrevano quotidiani colloqui telefonici”
9. “Vero che nel corso della degenza di **Persona_1** presso l’ **CP_5** dal 26.05.2014 al 30.05.2014 i signori **Parte_1** , **Parte_2** e **Controparte_1** , si recavano giornalmente a visitare il fratello”
10. “vero che in data 30.05.2014, alle ore 23,30 circa **Persona_1** nel corso di una conversazione con il fratello **Pt_1** lamentava dolori di testa”
11. “vero che in data 30.05.2014 dopo la caduta il signor **Persona_1** veniva lasciato nella sua stanza di degenza senza osservazione e che quando veniva trasferito era ancora vivo e ai due altri pazienti degenti nella stessa stanza veniva detto che sarebbe stato trasferito nel reparto di neurologia”
12. “vero che in data 31.05.2016 i familiari di **Persona_1** ne rinvenivano il corpo con evidenti ematomi sulla fronte e nell’arcata sopraccigliare sinistra”

13. “vero che i signori *Parte_1*, *CP_1* e *Pt_2* venivano convinti da una dottoressa dell’ *CP_5* dell’inutilità di procedere all’autopsia”

Si indicano a testi i signori:

- *Testimone_1*, via Roberto Ruffilli n. 6, Bollate;
- *Testimone_2*, via Leonardo da Vinci n. 1, Bollate;
- *Testimone_3*, Via Alessandro Manzoni n. 38, Baranzate di Bollate.
- Si chiede che l’Ill.ma Corte d’Appello voglia ordinare all’ *CP_5* di comunicare i dati e recapiti dei pazienti degenti nella stessa stanza del signor *Persona_1* nel momento del decesso e disporre l’audizione, sui capitoli di prova sopra articolati, con particolare riguardo alle condizioni di *Persona_1* dopo la caduta e la presenza di evidenti ematomi sul volto.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”

CHIEDONO

Che la causa venga posta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e, **stante l’ammissione al gratuito patrocinio** dei signori *Parte_1* e *Controparte_1*, **l’Avv. Iacona chiede la liquidazione delle spese di giudizio come da separata nota che si allega**, unitamente all’istanza ed al provvedimento di ammissione, peraltro già depositati in sede di iscrizione a ruolo.

Milano, 29 ottobre 2020

Per *Controparte_2* : FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DI ASST *Controparte_7*

Voglia l’Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:

In via preliminare: Dichiararsi l’inammissibilità dell’appello proposto dai Signori *Per_1* ai sensi degli artt. 342 e/o art. 348 bis c.p.c., non sussistendo una ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione nei confronti dell’ *Controparte_8* .

Nel merito: Respingere l’appello proposto nei confronti dell’ *Controparte_8* e confermare la sentenza del Tribunale di Milano nr. 5315/2019 nei capi ex adverso impugnati, rigettando comunque la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e mandando conseguentemente assolta l’appellata *Controparte_8* .

In subordine, nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello nei confronti dell’ [...] *Controparte_8*, dare atto del fatto che i Signori *Per_1* hanno ricevuto €10.000,00.= ciascuno

(quindi complessivamente €30.000,00.=), tramite offerta reale del 24/1/2017 a cura di *Controparte_9* , quale compagnia assicuratrice per la r.c. della convenuta, e ritenere detta somma interamente esaustiva dei danni azionati in giudizio.

Con vittoria di spese diritti competenze ed onorari.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* , *Controparte_1* e *Parte_2* hanno interposto appello avverso la sentenza n. 5315/2019 pubblicata il 5 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato le loro domande svolte nei confronti dell' *Controparte_10* [...] , compensando le spese di lite fra le parti e ponendo quelle della CTU a carico solidale fra le parti.

In riforma della sentenza impugnata hanno chiesto che venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell' *Controparte_5* nella causazione della morte di *Persona_1* e, per l'effetto, che venisse condannato al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi, subiti dagli attori, nella misura di € 427.260,00=. o nella diversa somma ritenuta di giustizia, dando atto che la convenuta in primo grado aveva versato di sua sponte € 10.000,00 a ciascun attore.

Si è costituita nel presente grado di giudizio l' *Controparte_10* che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 3 novembre 2020 le parti, mediante trattazione scritta, hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe richiamate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di memorie conclusive.

Prime di entrare nel merito delle singole censure articolate dagli appellanti, questa Corte ritiene opportuno sunteggiare i fatti e gli avvenimenti da cui ha tratto origine la presente controversia, chiaramente sunteggiati nella sentenza di primo grado qui di seguito riportati.

*“Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* *Controparte_1* e *Parte_2* hanno convenuto in giudizio l' *Controparte_10* chiedendo di accertarne le responsabilità in ordine al decesso del proprio congiunto *Persona_1* avvenuto in costanza di ricovero in data 30.5.2013, con condanna al risarcimento agli attori, iure proprio, di tutti i danni patiti.*

*Hanno dedotto che *Persona_1* fratello dei tre attori, era stato ricoverato presso l' [...] *Org_1* , reparto malattie infettive, in quanto affetto da persistente tosse e febbre; che il congiunto,*

benchè sieropositivo da anni, si trovava in relazione a tale patologia in condizioni stabili e sotto controllo farmacologico; che la sera del 30.5.2013, egli, nel recarsi in bagno veniva colto da un capogiro e cadeva a terra urtando violentemente la nuca; che dopo poche ore, a causa delle lesioni riportate a seguito della caduta, decedeva; che il decesso era riconducibile ad una mancata attività di vigilanza da parte della struttura poiché il congiunto, date le sue condizioni, poteva non essere stato in grado di muoversi autonomamente nonché, successivamente alla caduta, benchè sottoposto a TAC, era stato lasciato privo di osservazione nel periodo immediatamente successivo nonostante lamentasse cefalea. La difesa ha lamentato la dissonanza tra emergenze in cartella e informazioni raccolte dai compagni di stanza e dal personale infermieristico sullo stato di salute del congiunto e ha fatto riferimento alle risultanze della consulenza medico legale disposta dal Pubblico Ministero a seguito di denuncia dei famigliari attori, che aveva evidenziato una responsabilità della struttura ospedaliera. Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento di tutti i danni, quantificati nella somma di euro 489.060,00 alla struttura convenuta tenuto conto dell'età del paziente e della convivenza di quest'ultimo con il fratello Pt_1 .

Si è costituita l' Controparte_11 contestando la ricostruzione attorea; ha osservato come il sig. Persona_1 all'ingresso in reparto fosse del tutto vigile ed autonomo anche nella deambulazione, non richiedendo una vigilanza particolare o l'applicazione di mezzi di contenzione speciali; ha osservato che immediatamente dopo la caduta egli era stato soccorso adeguatamente, essendo stati svolti tutti gli esami e le visite del caso e che era stato sottoposto anche a visita da parte del neurologo e che il decesso era intervenuto rapidamente del tutto inaspettato; ha eccepito che gli esiti della consulenza medico legale svolta in sede penale non potevano essere opposti all'Ospedale ed ha infine eccepito la genericità delle allegazioni in punto danno essendo del tutto carente la descrizione degli elementi di fatto utili a fondare una liquidazione del danno da perdita parentale in via equitativa; ha contestato in ogni caso l'eccessività delle somme richieste”.

Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., espletata CTU medico legale, il Tribunale ha pronunciato la sentenza qui impugnata.

In sintesi, il Tribunale, sulla scorta della CTU esperita, ha rigettato la domanda risarcitoria, escludendo qualsivoglia responsabilità della struttura in ordine alle prestazioni sanitarie rese a favore di Per_1

[...]

Nello specifico ha, infatti, escluso che vi sia stata un'omissione nella vigilanza del paziente prima della caduta in ragione della mancanza di segnali indicativi di un rischio caduta in paziente autonomo e collaborativo e ha escluso negligenze e imperizie nelle cure prestate successivamente alla caduta sino al decesso del paziente.

Ha, infatti, affermato che “ *gli interventi eseguiti dopo la caduta sono stati rispettosi della concreta esigibilità*”: *il medico di guardia risulta essere intervenuto nell'immediatezza della caduta e, dopo avere visitato il paziente, richiese una TAC encefalo; questa venne eseguita tempestivamente, refertata e posta in visione al medico neurologo che visitò il sig. Per_1 alle 23,40 e cioè circa un'ora dopo l'esecuzione della TAC. Il neurologo diede quale prescrizione l'osservazione del paziente ogni due ore con ripetizione di TAC encefalo alla mattina successiva. Il decesso avvenne prima del trascorre di tale intervallo temporale, dopo che il paziente venne seguito dal personale che ne ha riferito lo stato di soggetto sveglio e l'evacuazione*”.

Con riferimento alle possibili cause del decesso, il Tribunale, sulla base della Ctu esperita, ha evidenziato quali potessero essere le prestazioni esigibili dal personale sanitario, tutte rispettate nel caso clinico concreto e ha escluso che il rapido decesso del paziente fosse riconducibile ad una lesione post traumatica.

Condividendo le conclusioni della Ctu il Tribunale ha affermato che “*i consulenti hanno accertato che “il trauma non è stato la causa di tutto, poiché il dato saliente è l'emorragia subaracnoidea (da probabile rottura di un aneurisma dell'arteria cerebrale media) associato ad una sottile falda di ematoma sottodurale sempre legata al sanguinamento di una malformazione in quella sede, cioè superficiale e non alla base del poligono del Org_2” (pag. 11 della relazione).*

Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori Per_1 chiedendo che, in sua riforma, venga accertata e dichiarata la responsabilità in capo all'Ospedale per il decesso del signor Per_1 [...] con conseguente condanna della Struttura al risarcimento del danno.

Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. sia priva di pregio e vada, pertanto, respinta. Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).

In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.

Osserva poi la Corte come il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, disposto alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., anche questa sollevata nel processo.

Venendo al merito delle singole censure articolate dagli appellanti si rileva come i medesimi, confutando le conclusioni peritali assunte in primo grado sulla base delle osservazioni dei C.T. attori, abbiano chiesto la riforma della sentenza impugnata con riferimento al capo che ha escluso la responsabilità dell' CP_5 nella determinazione del decesso del signor Persona_1 con conseguente condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

In primo luogo, lamentano che il Tribunale non abbia motivato la decisione di rendere non opponibile alla Struttura la CTU eseguita dal Pubblico Ministero in sede penale che avrebbe, invece, ravvisato profili di responsabilità in capo alla struttura stessa.

Affermano, infatti, che la relazione avrebbe dovuto essere equiparata ad una consulenza di parte; anzi “*posto che è stata svolta da un soggetto terzo nominato dalla Procura nell'ambito di un procedimento giudiziale dovrebbe essere ritenuta super partes*”.

Gli appellanti contestano poi le risultanze della CTU espletata in primo grado e ne chiedono la rinnovazione in questa sede, dolendosi che il Tribunale abbia fondato la propria decisione riportandosi alle sue conclusioni.

Evidenziano, invece, come la CTU non abbia dato una risposta certa ma solo “ipotetica” e che non abbia dato importanza al referto della Tac effettuata alle ore 22,41 ove si legge : “*Falda Falciforme iperdensa compatibile con ematoma subdurale frontoparietale Sin, dello spessore di 4,7 mm.*

Multipli focolai emorragici bilaterali e profondi, rispettivamente in sede nucleo-capsulare DS, nelle scissure silviane bilateralmente e in sede citternale e paracitternale SIN. Ematoma profondo come da focolare lacerocontusivo in sede temporale profondo SIN Ematoma subgaleale parieto- occipitale Sin....”.

Affermano, quindi, che la situazione era particolarmente critica e, quindi, meritevole di attento monitoraggio e sul punto richiamano le osservazioni allegate alla CTU effettuate dalla Consulente di parte, dott.ssa Per_2 sulle quali lamentano che il CTU non abbia dato adeguata risposta.

Evidenziano, infatti, che “ il paziente doveva essere in ogni caso monitorato in maniera attenta e scrupolosa anche stante le sue gravi condizioni cliniche e le patologie di base, tanto più che era emodializzato e stava andando incontro ad anemizzazione (progressive calo di S punti di emoglobinemia in quattro giorni).....una maggiore attenzione o richiesta di eventuale trasferimento in adeguata struttura o di consulenza esterna neurochirurgica non avrebbe lasciato probabilmente il Per_1 nel letto senza osservazione medica dalle 23:40 alle 01:20 (considerando l’intervallo di due ore tra un’osservazione e l’altra, richieste dal personale Sanitario)”.

Si dolgono, inoltre, che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non siano state del tutto rispettate le linee Guida, atteso che il neurochirurgo deve essere sempre interpellato, anche quando non vi sia una lesione operabile e si dolgono che anche nel caso in cui il decesso fosse stato conseguenza “di una emorragia subaracnoidea da rottura naturale di un aneurisma in sede silviana sinistra” i sanitari non ne abbiano tenuto conto, considerata anche la familiarità del Per_1 i cui entrambi genitori erano deceduti per patologie cerebrovascolari.

Contestano, infine, le affermazioni della CTU nella parte in cui anche in tale situazione nulla si sarebbe potuto fare.

Da ultimo, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto rilevante la circostanza della pregressa somministrazione al paziente di un farmaco in grado di “ scoagulare” e quindi di rendere più rapida una situazione di versamento.

Affermano, invece, che in assenza di un controllo, qualsiasi trauma potesse risultare fatale e si dolgono che tale argomento non sia stato minimamente trattato, né indagato dai CTU.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono insistono nella ammissione di una nuova CTU, nonché nella ammissione di mezzi istruttori già formulate in primo grado al fine di provare i quotidiani rapporti che vi erano tra i fratelli al fine della quantificazione del danno richiesto.

Reputa la Corte che l’appello non sia meritevole di accoglimento.

Occorre dapprima premettere che la domanda di risarcimento del danno da perdita del prossimo congiunto posta dagli appellanti debba necessariamente essere ricondotta nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine all’onere probatorio.

Ne deriva, pertanto, che seppur sia vero che la responsabilità della struttura e del personale sanitario nei confronti del proprio paziente è correttamente da ricondurre nell’alveo della responsabilità per inadempimento contrattuale di cui all’art. 1218 c.c., la responsabilità della struttura nei confronti dei congiunti lesi dalla morte del paziente, attesa l’impossibilità di trasmettere iure hereditatis tale tipologia

di danno, è da ricondurre nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che il diritto vantato dai congiunti è autonomo, seppur causalmente collegato all'inadempimento dei doveri di protezione e sorveglianza della struttura nei confronti del paziente (cfr. Cass. Civ., sez. III sez, n. 5590/2015).

Ed, infatti, per quanto attiene ai danni patiti dagli attori iure proprio, non avendo la struttura ospedaliera assunto alcuna obbligazione nei confronti dei fratelli del de cuius , i danni che questi ultimi lamentano non derivano dall'inadempimento di obbligazioni esistenti nei loro riguardi, bensì dal fatto illecito, consistente nell'aver provocato per colpa la morte del prossimo congiunto.

In quest'ottica, quindi, gravava sugli attori l'onere di provare innanzitutto il fatto illecito, ossia la condotta dell'ospedale, il nesso causale tra essa e l'evento dannoso (il decesso di *Persona_1* , nonché l'esistenza di una colpa in capo alla struttura medica e, infine, il danno consequenziale all'evento, ascrivibile alla categoria del c.d. danno da perdita del rapporto parentale.

Passando al merito della controversia, questa Corte ritiene che l'appello nei termini proposti non possa trovare accoglimento, risultando del tutto immune da censura la decisione impugnata.

Nel caso di specie, il tema centrale, su cui gli appellanti costruiscono l'intero atto di appello si fonda sulla mancanza di prova, non fornita dalla Struttura, del corretto adempimento alla prestazione dovuta e dell'assenza di colpa nel suo operato.

Tale censura viene svolta dagli appellanti con riguardo a diversi profili di negligenza individuati nella condotta dei sanitari e segnatamente con riguardo ai profili di seguito riassunti: non hanno dato corretta rilevanza alla TAC eseguita; non sono state rispettate le Linee guida che prevedono che un Neurochirurgo debba sempre essere interpellato anche quando la lesione non è operabile; i sanitari non hanno tenuto conto della familiarità del *Per_1* i cui genitori sono entrambi deceduti per patologie cerebrovascolari e che il *Per_1* sia stato sottoposto a emodialisi con somministrazione di farmaco per “scoagularlo”, rendendo così fatale ogni possibile trauma.

Tanto premesso, a giudizio di questa Corte, la valutazione in fatto del Tribunale è stata corretta ed è condivisibile.

L'accertamento in fatto dell'intera vicenda è stata oggetto di una complessa indagine svoltasi nel giudizio di primo grado, laddove il Tribunale, ha dato ingresso ad una CTU ritenendo correttamente non opponibile alla Struttura la CTU esperita dal Pubblico Ministero in primo grado, atteso che la consulenza redatta per conto del P.M. non può essere considerata alla stregua di una perizia “super partes” .

Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, i Consulenti hanno indagato in maniera molto analitica la condotta tenuta dai sanitari della Struttura, oggi appellata, valutandone la conformità alle regole dell'arte medica, nonché verificando l'ottemperamento del dovere di assistenza e di vigilanza assunto nei confronti del paziente, senza prescindere dalla previa individuazione e descrizione della situazione di fatto in cui i sanitari si sono trovati ad operare.

Deve, peraltro, ricordarsi che, specie in materia di responsabilità sanitaria, la perizia dell'Ufficio può divenire essa stessa fonte oggettiva di prova quando “ attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “ percipiente”, sicchè il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza in relazione a tale aspetto, come fosse fonte oggettiva di prova” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 4792/2013; Cass. Sez. III, sent. n. 6155/2009).

Gli accertamenti peritali offrono, infatti, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso causale secondo la regola del “ più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”, in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinante conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (Cass. Civ., sez. III, 28 luglio 2015, n. 15857). Ora la perizia espletata nel corso del giudizio di primo grado, che anche questa Corte ritiene pienamente condivisibile, anche a seguito delle osservazioni svolte dal CT di parte attrice, in questa sede riproposte, e delle repliche depositate dai Consulenti d'ufficio, in quanto basate su un completo esame, hanno evidenziato che, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, non è in alcun modo stata dimostrata, anche nei limiti dei criteri probabilistici comunemente adottati nell'ambito dei giudizi civili, la responsabilità dei sanitari.

I Consulenti tecnici del Tribunale, infatti, hanno acclarato l'assenza di responsabilità dei medici della CP_12 nella gestione e nella cura del sig. Persona_1 descrivendo dettagliatamente il comportamento dei sanitari dell' CP_5 convenuto che è stato ritenuto corretto.

I CTU, infatti, hanno rilevato che in seguito alla caduta del signor Per_1 mentre si recava in bagno sia stato immediatamente soccorso dal personale infermieristico che richiedeva l'intervento del medico di guardia, il quale dopo aver visitato il paziente, richiese una TAC encefalo, che venne eseguita

tempestivamente e visionata dal neurologo, il quale visitò il paziente alle ore 23,40 dopo circa un'ora dall'esecuzione della TAC.

Conformemente alle linee guida, il neurologo prescrisse l'osservazione del paziente ogni due ore con ripetizione della TAC encefalo alla mattina successiva.

Deve poi rilevarsi come il deterioramento neurologico del paziente, pacificamente rapidissimo, “ non poteva avere alcuna chance di trattamento medico- chirurgo utile” (cfr. pag. 10 CTU).

Secondo, infatti, i CTU anche nel caso in cui il medico neurologo avesse richiesto parere neurochirurgico, quest'ultimo avrebbe escluso ogni intervento, stante le precarie condizioni del paziente, dal momento che non poteva essere eseguito alcun trattamento invasivo.

Come, peraltro, già evidenziato dal Tribunale anche qualora si fosse sottoposto il paziente a visita neochirurgica l'*exitus* fatale sarebbe stato il medesimo.

Infatti, il rapido deterioramento neurologico non avrebbe consentito alcun trattamento medico chirurgico utile ed il parere del neurochirurgo, ancorchè richiesto, avrebbe ragionevolmente escluso una indicazione chirurgica, stante le condizioni del paziente.

Nel replicare alle osservazioni del consulente di parte attrice hanno precisato che il decesso non è compatibile con lo sviluppo di una lesione post- traumatica, essendo sopraggiunto improvvisamente e, quindi, riconducibile a un risanguinamento acuto improvviso di aneurisma o ad arresto cardiaco.

Secondo i CTU, infatti, “ *il trauma non è stato la causa di tutto*” e “ *secondo comuni conoscenza mediche, si precisa che il sig. Per_1 è giunto a morte così rapidamente non a causa dello sviluppo di una lesione postraumatica, perché ciò si manifesta clinicamente con un graduale e progressivo peggioramento dal momento del trauma con paziente perfettamente sveglio (e non in coma o soporoso) fino all'evento morte. Mentre solo un risanguinamento improvviso acuto di un aneurisma (o un arresto cardiaco) spiegano le modalità con cui il Sig. Per_1 è morto*”.

La caduta del paziente non ha avuto alcun ruolo causale nel decesso e i periti hanno evidenziato che in ogni caso le prestazioni sanitarie sono state esenti da censura.

Ed, infatti, in caso di caduta dovuta ad emorragia subaracnoidea da rottura naturale di un aneurisma in sede silvana sinistra, tenuto conto delle gravi condizioni cliniche e delle patologie di base del paziente, nulla poteva e doveva essere fatto; mentre in caso di caduta accidentale con conseguente grave trauma cranico si sarebbe dovuta effettuare una TAC all'encefalo e quindi una visita dello specialista neurologo con successivo monitoraggio clinico- infermieristico, e, in assenza di modifiche cliniche,

un'ulteriore TAC di controllo distanza di 6-12 ore, prestazioni di fatto rese, essendo stata effettuata la TAC encefalo, la visita del neurologo e la disposizione in ordine al controllo clinico- infermieristico.

Come già rilevato dal Tribunale, inoltre, il diario infermieristico e le annotazioni registrate dal neurologo non segnalano fatti che abbiano le caratteristiche di allarmi particolari; i consulenti hanno in effetti spiegato che per questo scenario il peggioramento avviene gradualmente e progressivamente con segnali neurologici focali e compromissione dello stato di coscienza.

Non può poi essere condivisa l'affermazione dell'appellante nella parte in cui censura la sentenza per aver il Tribunale ritenuto " certa" la causa del decesso, ove, invece gli stessi consulenti qualificano la loro ipotesi come altamente probabile, atteso che non si è di fronte ad ipotesi di causa ignota, essendo agli atti chiare le risultanze peritali che escludono ogni profilo di responsabilità in capo ai sanitari della Struttura.

Prive di rilievo risultano, infine, le doglianze dell'appellante secondo cui i CTU non avessero minimamente trattato, né indagato il fatto che il paziente fosse stato sottoposto a emodialisi e gli fosse stato somministrata eparina, con ciò rendendo qualsiasi trauma fatale, atteso che trattasi di doglianza genericamente sollevata, non avendo neppure indicato quale sarebbe stato il trattamento corretto da esigere dai sanitari.

Sulla base di quanto qui rappresentato, l'appello va, quindi, respinto e confermata la sentenza impugnata.

Quanto alle prove orali non ammesse in primo grado e qui riproposte volte ad indagare i legami parentali tra gli appellanti e il de cuius *Persona_1* ritiene la Corte che le stesse, atteso l'esito del gravame, risultino superflue.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale degli appellanti, signori *Per_1* ed in favore dell' *Controparte_11* .

Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della causa e alla media difficoltà dell'attività prestata, in euro 13.560,00 di cui euro 4.180,00 per la fase di studio, euro 2.430,00 per la fase introduttiva ed euro 6.950,00 per quella decisionale, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012-

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* *Controparte_1* e *Parte_2* avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5315 pubblicata in data 5 giugno 2019, ogni diversa istanza, deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello, confermando di conseguenza integralmente la sentenza impugnata;
- 2) condanna *Parte_1* *Controparte_1* e *Parte_2* in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in complessivi euro 13.560,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a.
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012-

Milano, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021

Il Consigliere Estensore

dott.ssa. Elena Mara Grazioli

Il Presidente

dott. Walter Saresella